

NICHVS STUDIO

Vita · vertical de saúde — A inteligência em movimento perpétuo

PROPOSTA COMERCIAL

Plataforma Vita + Consultoria de Modelagem da Jornada para o Hospital Evangélico de Londrina

Evolução tecnológica de ponta a ponta, rumo à Inteligência Infraestrutural

Cliente	Hospital Evangélico de Londrina
Preparada para	Superintendência e Diretoria Técnica
Preparada por	Nichvs Tecnologia ME
Data	Junho de 2026
Validade da proposta	30 dias
Versão	v1.0

1 · Sumário Executivo

O Hospital Evangélico de Londrina opera em larga escala — faturamento da ordem de R\$ 18 milhões/mês entre SUS, convênios e plano próprio — e, como toda operação hospitalar dessa complexidade, convive com perdas estruturais difusas em três frentes: a operação e o ciclo de receita (glosa, no-show, salas e exames); os materiais, medicamentos e OPME; e a segurança do paciente. Individualmente parecem pequenas; somadas, decidem a margem do hospital.

A plataforma **Vita** (família NICHVS STUDIO), combinada à consultoria de modelagem da jornada, ataca as três frentes com automação assistida e interoperabilidade. O núcleo operacional, já modelado, projeta **R\$ 270,5 mil/mês** com **payback de 7 meses e ROI de 3,66x em 36 meses**. As extensões verticais VitaMed e VitaCare adicionam um potencial incremental de **~R\$ 335,7 mil/mês**, elevando o benefício potencial consolidado a **~R\$ 606 mil/mês** — sobre premissas a validar na Fase 0.

2 · Entendimento do Desafio

As frentes de perda são as premissas de trabalho do modelo de valor, a confirmar com os números reais da instituição no diagnóstico (Fase 0):

2.1 · Operação & ciclo de receita

- **Glosa:** ~4% sobre o faturamento (~R\$ 720 mil/mês), com parcela técnica evitável por estruturação TISS e auditoria assistida.
- **Faturamento manual:** ~2.000 horas/mês em auditoria e montagem de contas.
- **No-show:** ~18% sobre ~12.000 agendamentos/mês — receita não realizada e capacidade ociosa.
- **Salas & exames:** 8 salas com utilização aquém do potencial e ~6% de exames duplicados sobre ~20.000/mês.

2.2 · Materiais, medicamentos & OPME

- **Subfaturamento e glosa de material/OPME,** rastreabilidade incompleta, ruptura e desperdício de estoque, e o ciclo manual de autorização e consignação. Detalhado no Anexo A.

2.3 · Segurança do paciente & desfechos

- **O custo invisível:** eventos adversos evitáveis que prolongam internação, travam a rotatividade de leitos e geram reinternação, reabordagem cirúrgica e procedimentos mais longos. Detalhado no Anexo B.

3 · Solução Proposta

3.1 · Núcleo operacional — plataforma Vita

Módulo	O que resolve no HEL
VitaScrape · Interoperabilidade	HL7/FHIR, RNDs e TISS; conexão a HIS/ERP, laboratórios e convênios — eventos clínicos e administrativos sem digitação dupla.

Módulo	O que resolve no HEL
VitaDoc · Ciclo de Receita	Leitura de guias, laudos e contas; estruturação TISS, prevenção de glosas e auditoria documental com validação humana.
VitaMatch · Alocação & Priorização	Priorização de leitos, filas cirúrgicas e exames por critérios clínicos e operacionais — apoio à decisão, palavra final humana.
VitaFlow · Torre de Comando	Ocupação, no-show e indicadores em tempo real; alertas, RBAC e auditoria imutável por papel.

3.2 · Extensões verticais

Módulo	Eixo de valor
VitaMed · Materiais, Medicamentos & OPME	Fecha o elo entre consumo físico e receita líquida: anti-subfaturamento, glosa de material/OPME, rastreabilidade, estoque e consignação. (Anexo A)
VitaCare · Segurança do Paciente & Desfechos	Vigilância assistiva de risco (deterioração, queda, LPP, sepse), bundles de prevenção e gestão de desfechos — menos permanência, reinternação e reabordagem. (Anexo B)

3.3 · Consultoria — Modelagem da Jornada

Desenho metodológico da transição da operação atual até a Inteligência Infraestrutural, com governança, segurança e conformidade (CFM, ANVISA, ANS/TISS, RNDS e ONA) tratadas como engenharia. A IA é assistiva e opera com humano no comando: apoia decisões, nunca as substitui.

4 · Abordagem & Metodologia

Condução sob as melhores práticas e frameworks globais, adaptados à realidade regulatória da saúde brasileira:

COBIT · ISO/IEC 27001 · NIST CSF · DAMA-DMBOK · MLOps · DevSecOps · SAFe · Scrum/Kanban · Responsible AI · HL7 FHIR · IEC 62304 / ISO 13485 (SaMD).

5 · Escopo & Entregáveis

1. Fase 0 — Diagnóstico, governança e segurança: baseline das premissas, RACI, bases legais (LGPD), arquitetura de segurança e alta disponibilidade.
2. Fase 1 — VitaDoc: prova de valor no ciclo de receita (glosa e horas de faturamento).
3. Fase 2 — VitaFlow: torre de comando e redução de no-show.
4. Fase 3 — VitaMatch: alocação de leitos, salas e filas.
5. Fase 4 — VitaScrape: interoperabilidade plena (FHIR/RNDS/TISS).
6. Fase 5 — VitaMed: materiais, medicamentos & OPME (Anexo A).
7. Fase 6 — VitaCare: segurança do paciente & desfechos (Anexo B).

Entregáveis-padrão por fase: matriz RACI, checklist ISO/IEC 27001, plano de continuidade (DR/HA), mapa de homologação, KPIs/SLAs, política de IA Responsável e cronograma detalhado.

6 · Roadmap / Cronograma

Fase	Escopo	Go-live (mês)
0	Diagnóstico, governança & segurança	Mês 1 (início)
1	VitaDoc — ciclo de receita	Mês 3
2	VitaFlow — torre de comando	Mês 5
3	VitaMatch — alocação & priorização	Mês 8
4	VitaScrape — interoperabilidade	Mês 11
5	VitaMed — materiais, medicamentos & OPME	Mês 14
6	VitaCare — segurança do paciente	Mês 17

Rampa até run-rate pleno de aproximadamente 4 meses após cada go-live.

7 · Modelo de Investimento

O investimento separa a implantação (única, por fase) da assinatura recorrente. A implantação é faturada por marco de entrega — go-live de cada fase — diluindo o capex do hospital; a recorrência escala à medida que cada módulo entra em operação.

7.1 · Implantação por fase (investimento único)

Fase	Escopo	Investimento
Fase 0	Diagnóstico · governança · segurança/HA	R\$ 90.000
Fase 1	VitaDoc — ciclo de receita	R\$ 150.000
Fase 2	VitaFlow — torre de comando	R\$ 130.000
Fase 3	VitaMatch — alocação & priorização	R\$ 160.000
Fase 4	VitaScrape — interoperabilidade	R\$ 180.000
Fase 5	VitaMed — materiais, medicamentos & OPME	R\$ 160.000
Fase 6	VitaCare — segurança do paciente	R\$ 170.000
Total	Implantação ponta a ponta (6 módulos)	R\$ 1.040.000

7.2 · Assinatura — bundle institucional (mensal)

Módulo	Mensal	Anual
VitaScrape · Interop (FHIR/RNDS/HL7)	R\$ 10.000	R\$ 120.000
VitaDoc · ciclo de receita	R\$ 8.000	R\$ 96.000
VitaMatch · alocação & priorização	R\$ 8.000	R\$ 96.000

Módulo	Mensal	Anual
VitaFlow · torre de comando	R\$ 9.000	R\$ 108.000
VitaMed · materiais & OPME	R\$ 9.000	R\$ 108.000
VitaCare · segurança do paciente	R\$ 10.000	R\$ 120.000
Bundle institucional (6 módulos)	R\$ 49.000	R\$ 588.000

Ativação modular: o hospital liga cada módulo conforme comprova valor — sem contrato monolítico. Alternativa institucional: contrato anual único (implantação + recorrente) com desconto de volume.

7.3 · Potencial de benefício consolidado (run-rate pleno)

Eixo de valor	R\$/mês	R\$/ano
Núcleo operacional (4 módulos) — modelado	270.500	3,25 mi
VitaMed — materiais, medicamentos & OPME	141.750	1,70 mi
VitaCare — segurança do paciente & desfechos	194.000	2,33 mi
Potencial consolidado	606.250	7,28 mi

7.4 · Retorno

O núcleo operacional já está modelado e ancora a decisão: **ROI de 3,66× em 36 meses, payback de 7 meses e VPL de R\$ 5,21 mi** (cenário base). VitaMed e VitaCare são incrementais e melhoram esse retorno; mantidas as proporções de rampa e cenário do modelo, o programa consolidado projeta payback inferior a 12 meses e ROI na ordem de 3–5× — a ser consolidado na planilha atualizada com os dois novos eixos.

Os indicadores derivam do modelo de valor Vita @ HEL. As premissas operacionais (faturamento, glosa, no-show, salas, exames, materiais/OPME e eventos de segurança) são ilustrativas e serão validadas com os números reais do hospital no baseline (Fase 0). Não constituem oferta vinculante nem aconselhamento financeiro. Funções clínicas permanecem assistivas, sob decisão humana e enquadramento CFM/ANVISA.

8 · Premissas & Exclusões

- Acessos, dados e pontos focais (TI, faturamento, corpo clínico e diretoria) fornecidos em tempo hábil.
- Integrações dependem de cooperação dos fornecedores dos sistemas legados (HIS/ERP/PACS) do hospital.
- Licenças de terceiros e infraestrutura on-premise, quando aplicáveis, não estão inclusas salvo indicação expressa.
- Funções com componente clínico dependem de enquadramento regulatório (CFM/ANVISA) e aprovação institucional antes de qualquer operação.

9 · Termos Comerciais

- Validade desta proposta: 30 dias a partir da data de emissão.

- Implantação faturada por marco (go-live de cada fase); assinatura mensal por nota fiscal.
- Reajuste anual pelo IPCA; tributos conforme legislação.
- Contratação formalizada por Contrato de Prestação de Serviços e respectiva Ordem de Serviço (SOW).
- Metas e benefícios são projeções de planejamento, confirmados após o baseline na Fase 0.

10 · Próximos Passos

1. Aprovação desta proposta e assinatura do contrato / Ordem de Serviço.
2. Workshop de Diagnóstico (Fase 0) com TI, faturamento, corpo clínico e diretoria.
3. Kickoff do VitaDoc e início da prova de valor no ciclo de receita.

Contato: contato@nichvs.tech · nichvs.studio · nichvs.tech

Nichvs Tecnologia ME · CNPJ 28.954.962/0001-07 · Florianópolis/SC